

## **09 - 02-TD Bactériologie : HYGIENE HOSPITALIERE ET GESTION DES RISQUES - Pr. LOQMAN**

(0:00 - 1:16)

Bonjour, nous allons traiter aujourd'hui, lors de cette deuxième séance de travaux dirigés de bactériologie, l'hygiène hospitalière et la gestion des risques. Les objectifs pédagogiques fixés de cette séance sont d'abord savoir définir une infection nosocomiale ainsi que les facteurs de risque et les modalités de son acquisition, acquérir des connaissances en matière d'hygiène hospitalière, comprendre comment améliorer la maîtrise des risques infectieux et enfin savoir les étapes de la gestion d'un accident d'exposition au sang. Les infections associées aux soins constituent un problème majeur de santé publique, ces infections augmentent la morbidité, la mortalité des locaux d'hospitalisation, ils sont majoritairement exogènes via une transmission croisée manuportée le plus souvent ou aéroportée et par l'exposition des patients aux manœuvres invasives, par l'installation des dispositifs médicaux tels que les cathéters et l'intubation.

(1:18 - 2:03)

L'hygiène est l'ensemble des mesures de prévention de la survenue d'une colonisation ou d'une infection associée aux soins à travers des proportions standards et complémentaires. Le comité de lutte contre les infections nosocomiales, présent obligatoirement dans chaque établissement hospitalier, est une instance pluridisciplinaire dont la mission principale est d'élaborer la politique de lutte contre les infections nosocomiales. Une infection nosocomiale ou une infection associée aux soins est une infection acquise par un patient au cours des soins délivrés à l'hôpital.

(2:03 - 3:38)

Elle n'est ni présente ni en incubation avant le geste médical, à part 8 heures à 62 heures après le geste, 30 jours après une intervention chirurgicale, jusqu'à un an après l'installation d'un implant ou une prothèse. Le corps humain est un réservoir de micro-organismes, ces derniers sont présents sur la peau, dans toutes les cavités ou dans certains liquides biologiques, par exemple la salive, contient environ 100 millions de bactéries, donc la contamination peut être transportée par l'ongle et en distribue une contamination endogène si le patient est infecté par ses propres germes, suite à la modification de sa flore commensale par un contact avec l'environnement hospitalier contaminé ou suite à un acte invasif ou la consommation d'antibiotiques. Si le microbe provient de l'extérieur de la personne infectée, par exemple une autre personne telle que le personnel soignant et les visiteurs, ou à travers un environnement hospitalier contaminé, on va parler dans ce cas d'une contamination exogène.

(3:42 - 4:29)

Les facteurs intrinsèques favorisant sont les âges extrêmes de la vie et les prématurés, le sexe,

par exemple les infections urinaires sont plus fréquentes chez les femmes, l'adhérence de séjour qui augmente l'incidence des infections et bien sûr l'intervention chirurgicale. Toutes les prothèses, les actes invasifs, les drains, les cathéters, l'adhérence de maintien en place des prothèses, l'utilisation mal maîtrisée des antibiotiques constituent les facteurs extrinsèques favorisant. La lutte contre les infections nosocomiales est une priorité et fait partie des critères de qualité des établissements de soins.

(4:30 - 5:04)

L'hygiène hospitalière constitue le paramètre clé de cette qualité. Une hygiène tout court est définie comme l'ensemble des principes et des pratiques visant à préserver ou améliorer la santé. L'hygiène hospitalière ou liée aux soins est un ensemble de mesures curatives qui visent à limiter les foyers infectieux et préventifs qui visent à limiter les voies de contamination de l'infection dans un contexte bien ciblé.

(5:05 - 5:37)

L'hygiène reste le seul moyen de prévention contre ces infections associées aux soins. Il concerne les patients, le personnel soignant et l'environnement hospitalier. Les principales mesures de prévention sont les précautions standards comme le port de gants, les blouses et les masques, les précautions complémentaires principalement l'hygiène des mains et d'autres précautions particulières.

(5:37 - 6:10)

Le seul but est d'interrompre la chaîne de l'infection. Avant de détailler ces précautions, nous allons nous arrêter sur la définition de quelques termes en relation avec le concept d'hygiène. La CPSI par exemple est définie comme l'ensemble des mesures propres à empêcher tout apport d'agents infectieux au niveau de surface inerte ou biologique.

(6:10 - 6:53)

L'antisepsie est une opération au résultat momentané permettant d'éliminer les agents infectieux qui suivent un tissu vivant, alors que la désinfection c'est l'antisepsie de surface inerte. Le tableau suivant montre l'effet de certains produits désinfectants sur les germes pathogènes. Par exemple, l'alcool est actif sur les bactéries gramme positif et gramme négatif, les mycobactéries, alors qu'il n'a pas d'effet sur l'espèce.

(6:56 - 7:35)

Les précautions standards sont mises en œuvre par tout soignant lors de tout soin à tout patient quel que soit son statut infectieux, permettant d'éliminer le risque de transmission de la maladie. L'objectif est de protéger les patients et le personnel des agents infectieux véhiculés par le sang.

et les liquides biologiques. Le tableau suivant détaille ces précautions standards.

(7:37 - 7:56)

L'hygiène hospitalière égale l'hygiène des mains. Parce que les mains constituent le principal mode de transmission croisée des micro-organismes, ces derniers sont capables de survivre sur les mains. Par exemple, les enterobactéries restent vivantes 6 à 120 minutes sur les mains.

(7:58 - 8:40)

Donc, l'hygiène des mains est considérée comme la mesure la plus efficace pour réduire significativement le taux de l'incidence des infections nosocomiales à transmission croisée par diminution jusqu'à 99% de la flore cutanée transitoire. Il vise à éliminer surtout la flore transitoire telle que les bactéries gramme positives et gramme négatives, les levures et les virus. La figure suivante montre les 5 indications du lavage des mains définies par l'Organisation mondiale de la santé.

(8:41 - 8:54)

1. Avant de toucher au patient. 2. Avant un geste aseptique. 3. Après un risque d'exposition à un liquide biologique.

(8:55 - 9:16)

4. Après avoir touché un patient. 5. Après avoir touché l'environnement du patient. Les méthodes de révérence du lavage des mains sont soit un lavage avec l'eau et le savon, soit l'utilisation des solutions hydroalcooliques.

(9:16 - 9:51)

L'objectif est d'éliminer la flore transitoire. Le lavage des mains ne semble pas être un réflexe naturel, bien que le récent épisode du Covid-19 que nous vivons actuellement a permis de le qualifier comme un excellent rempart contre la propagation du coronavirus. L'importance accordée au lavage des mains a fait de cet acte une journée mondiale du lavage des mains que nous célébrons chaque année le 15 octobre.

(9:53 - 10:40)

Les précautions complémentaires sont destinées à compléter les précautions standards, surtout chez les patients suspects d'être colonisés ou infectés par des micro-organismes hautement transmissibles. Les trois catégories des précautions complémentaires reposent surtout sur les trois modes de transmission des micro-organismes, à savoir la transmission par contact direct ou indirect, via du gouttelet contaminé ou de l'air pollué. Pour les infections transmises selon plusieurs modalités, une combinaison des trois catégories de précautions peut être utilisée.

(10:43 - 11:10)

Le tableau suivant détaille ces précautions complémentaires. Enfin, un petit mot sur les accidents d'exposition au sang. Il s'agit de tous les accidents ou incidents en contact avec le sang ou un liquide biologique contaminé par du sang et comportant une effraction tétanique telle que les fécures ou une projection sur les muqueuses.

(11:10 - 11:47)

Le risque est de vous contaminer, mais aussi vous pouvez être porteur d'un virus sans le savoir et de contaminer le patient à partir de vous-même. C'est pour cela les accidents d'exposition au sang font l'objet d'une réglementation. La conduite à tenir médicale et médico-légale, la stratégie de prévention des accidents d'exposition au sang et les obligations légales de l'employeur sont définies par un ensemble de circulaires qui s'inscrivent dans le cadre général de l'analyse et de la prévention des risques professionnels.

(11:48 - 12:40)

La figure suivante illustre les conduites à tenir en cas d'accident d'exposition au sang ou de liquide biologique. D'abord, il faut réaliser les premiers soins en urgence tels que le rinçage à l'eau ou bien au sérum physiologique ou appliquer un antiseptique sur la zone lésée, puis contacter le médecin référent afin d'évaluer le risque et de démarrer un traitement si nécessaire, contacter le médecin de travail pour déclarer l'accident du tract. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre entière disposition pour tout complément d'informations.